

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/25/3

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים), התשפ"ג – 2022

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בתוספת השנייה, בפרט 22א, בסופו יבוא:

"(ג) סל שירותי בריאות הנפש לגמילה

(1) שירותי אשפוז במוסדות משרד הבריאות (כולל עמותות הממומנות על ידי המשרד);

(2) שירותים מרפאתיים;

(3) גמילה תוך ביתית;

(4) מתן התכשירים המפורטים להלן במסגרת שירות מרפאתי לפי

פסקה (2): "Methadone, Buprenorphine, Buprenorphine+Naltrexone".

2. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 3, פרט משנה 3 שכותרתו "סל שירותי הבריאות הנפש לגמילה" – יימחק.

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע את השירותים הרפואיים להם זכאי כל תושב במסגרת סל שירותי הבריאות. על פי החוק קופות החולים הן האחראיות למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השנייה, ומשרד הבריאות אחראי למתן שירותי הבריאות המצויים בתוספת השלישית. בשנת 1990 במסגרת הוועדה בראשותה של השופטת שושנה נתניהו הוחלט על רפורמה בשירותי בריאות הנפש. ההמלצות אומצו בשנת 1994 כחלק מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בשנת 2012 פורסם צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק), אשר יושם בשנת 2015. על פי הצו, שירותי האשפוז והשירותים האמבולטוריים בבריאות הנפש יעברו מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופת החולים, מלבד האחריות על טיפול בהתמכרות שישאר במשרד הבריאות. בעקבות העברת הרפורמה באופן חלקי, נוצר פיצול וסרבול הפוגע במענה הטיפולי המתייחס לתחלואה כפולה שבה מתקיימים בו-זמנית מחלה נפשית והתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים. מתמודדים עם תחלואה כפולה כאמור נמצאים באחריותם של שני גופים – משרד הבריאות וקופות

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

החולים. כפועל יוצא מכך הם נותרים ללא מענה ומוחרגים משירותים שונים ללא כל הצדקה רפואית, אלא פרוצדורלית בלבד, דבר הכרוך בסרבול בירוקרטי, ומהווה קיפוח ואי שוויון.

לא אחת מתמודדים עם מחלת נפש נעזרים בחומרים פסיכו-אקטיביים בכדי להקל על סבלם וההתמכרות היא תוצאה של "טיפול עצמי" במחלה הנפשית. הספרות המקצועית מתייחסת לשלושה מצבים של תחלואה כפולה מעין זו: המחלה הנפשית קדמה להתמכרות; ההתמכרות קדמה למחלה הנפשית והובילה אליה; שתי התופעות - ההתמכרות והמחלה הנפשית - התפתחו באותו הזמן.

תהליכים מוחיים הקשורים למחלה נפשית ולהתמכרות ממוקמים באותם אזורים מוחיים. קיומן של שתייהן בעת ובעונה אחת מתאפיין בבעיות ייחודיות. אנשי המקצוע בתחום הפסיכיאטריה מצביעים על החשיבות של האבחנה המבדלת והטיפול המותאם, ולפיכך הטיפול חייב להיות בשתי המחלות בידי אותם מטפלים תוך יצירת רצף טיפולי אינטגרטיבי והוליסטי.

לא קיים אומדן מדויק לגבי היקף התופעה של מתמודדים עם תחלואה כפולה כאמור ואין נתונים אודות שכיחותה. אולם, מומחים מעריכים כי התופעה של שילוב פסיכוסוציאלי להתמכרות, שכן בהרבה מכפי שניתן לשער. הטענה הרווחת בקרב המומחים בתחום היא שמדובר על כמחצית מהמתמודדים עם מחלת נפש. ממדי התופעה המשוערים מחייבים להתאים טיפול שעונה על שתי הבעיות גם יחד.

התוצאה של חלוקת תחומי האחריות בין משרד הבריאות לקופות החולים, היא שהטיפול הפסיכיאטרי אינו יעיל כאשר לא ניתן למטופל במקביל אליו גם טיפול פסיכוסוציאלי להתמכרות, שכן המטופל ממשיך להשתמש בחומרים פסיכו-אקטיביים וחוזר לנקודת ההתחלה. זאת ועוד, הסיכוי כי למטופל תהיה מוטיבציה לפנות לטיפול נפרד בהתמכרות הוא נמוך.

הגורמים האמונים על הטיפול מפוצלים בין תחומי אחריות שונים, והמטופלים אינם יכולים לקבל מענה ראוי והוליסטי למחלתם. כך למשל, קופות החולים המפיקות מנויים לטיפול אמבולטורי ואשפוזי, יבטלו את המנוי במידה וההפניה קשורה לרפואת התמכרויות, בטענה שהתחום לא תחת סמכותם. בשל הפיצול הטיפולי קיים קושי רב ביצירת רציפות טיפולית. דבר זה עלול להוביל להחמרה במצב הנפשי של המטופל, אשפוזים חוזרים במחלקות פסיכיאטריות בבתי החולים, כישלון בהליך השיקום, פגיעה באיכות חיי המטופלים ובני משפחותיהם ועוד.

ברמת המיקרו, יש בזבוז משאבים על טיפול עקר בנפגעי הנפש, כגון תשלום על אשפוזים חוזרים ומינויים טיפוליים עבור שירותי בריאות נפש אמבולטוריים.

ברמת המאקרו, ישנה פגיעה כלכלית עקיפה בתל"ג בשל היעדר יכולת להשתקם, להשתכר ולהיות גורם יצרן בחברה. בעקיפין יש הפסד נוסף גם של בני המשפחה שיחסירו ימי עבודה או יעזבו את מקום עבודתם בכדי לטפל במתמודד.

לפיכך מוצע להעביר את האחריות לטיפול בהתמכרויות לאחריות קופות החולים, במטרה לתת מענה נגיש וזמין בקהילה לכלל המטופלים בהתמכרות, וכן מענה טיפולי לאוכלוסייה מורכבת הנושאת אבחנה כפולה, לייעל את הטיפול והשיקום ולטייב את איכות הטיפול.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/1828 ; פ/24/1917) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/2041).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/24/1405) ועל ידי חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואמילי חיה מואטי (פ/24/2155).

הצעת החוק זהה לפ/24/2155 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)